

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-06 至 2026-06-12。每篇文章单独成页，按 “标题、结论、主要内容、关键信息、启示” 快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库 38	PDAT 发表日期 33	MDAT 记录更新 274	精选入页 5
----------------	-----------------	------------------	-----------

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

- 下载 PDF
- 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-12 检索；窗口为 2026-06-06 至 2026-06-12，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。官方计数为 EDAT 38、PDAT 33、MDAT 274，去重候选池 280 条。本日沿用 5 papers/day 和 pubmed-history.json 去重，选择 5 篇未跨日重复 PMID；ADC 方向今日未重复选入，因为近几日已覆盖 polatuzumab/loncastuximab 等 ADC 信号，今天新增高优先级更集中在 CNS 预防、双抗、CAR-T 药代和免疫微环境机制。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	CNS 预防 / LBCL / HD-MTX	超高危 large B-cell lymphoma	42274647	超高危 LBCL 的 HD-MTX CNS 预防：1,923 例国际多中心回顾分析未显示 CNS 复发显著下降	打开文献
2	双抗 / CD20xCD3 / R/R DLBCL	ASCT 不适合 R/R DLBCL	42269085	STARGLO 3 年随访：固定疗程 glofitamab-GemOx 在 ASCT 不适合 R/R DLBCL 中持续优于 R-GemOx	打开文献
3	CAR-T / lymphodepletion / 药代	R/R large B-cell lymphoma	42269079	R/R LBCL CAR-T 中氟达拉滨暴露窗口：前瞻性 PK 监测提示 AUC 适中者 PFS 更优	打开文献
4	免疫微环境 / EBV+ DLBCL / 转化机制	EBV 阳性 DLBCL	42271039	EBV+ DLBCL 免疫生物学：系统抗病毒 T 细胞缺陷与 LMP1 驱动的抑制性髓系生态位共同塑形	打开文献
5	免疫治疗机制 / 巨噬细胞 / DLBCL 耐药	DLBCL	42270158	DLBCL 肿瘤来源 HMGB2 外泌体轴：TRIM65 介导 NLRP3 降解，推动 M2 样巨噬极化和抗 CD20 耐受	打开文献

超高危 LBCL 的 HD-MTX CNS 预防：1,923 例国际多中心回顾分析未显示 CNS 复发显著下降

High-Dose Methotrexate as CNS Prophylaxis in Ultra High-Risk Large B-Cell Lymphoma: An International Multicenter Analysis.

CNS 预防 / LBCL / HD-MTX

超高危 large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中: 2026-06-12 近 7 天新增入库/发表/更新

P

符合 CNS-IPI 5-6、特定结外部位或 ≥3 结外部位的超高危 LBCL 患者

I

HD-MTX CNS 预防

C

未使用 HD-MTX CNS 预防

O

3 年 CNS 复发率、孤立 CNS 复发率、6 个月 landmark CNS 复发

结论

这项 JCO 国际多中心回顾分析合并 1,923 例超高危 LBCL 患者，比较使用或未使用大剂量甲氨蝶呤 (HD-MTX) 进行 CNS 预防。无论总体超高危人群、孤立 CNS 复发，还是 6 个月 landmark 响应人群，HD-MTX 均未显著降低 3 年 CNS 复发率。研究支持重新审视“超高危即常规 HD-MTX 预防”的证据基础。

主要内容

- 研究纳入符合至少一项超高危标准的 LBCL 患者：CNS-IPI 5-6 分、睾丸/肾或肾上腺/乳腺受累，或 ≥3 个结外部位。
- 总体分析包括未用 HD-MTX 1,051 例和使用 HD-MTX 872 例；主要终点为诊断后 CNS 复发率，包括孤立或伴随系统复发。
- 3 年 CNS 复发率为 9.3% vs 8.1%，调整后 HR 1.13（95% CI 0.82-1.57）；孤立 CNS 复发为 5.9% vs 5.7%，调整后 HR 1.03。
- 6 个月无进展响应患者的 landmark 分析同样未见差异：3 年 CNS 复发率 6.7% vs 6.6%，调整后 HR 0.95。

关键信息

- 作者：Matthew R Wilson、Katharine L Lewis、Amy A Kirkwood、Kate Cwynarski、Chan Y Cheah、Tarec C El-Galaly 等。
- 核心数据：1,923 例超高危 LBCL；HD-MTX 872 例；3 年 CNS 复发率未显著下降。
- 临床问题：CNS 预防不是 CNSL 治疗，但直接影响 DLBCL 高危人群的治疗路径、毒性负担和试验分层。
- 方向标签：LBCL、CNS relapse、CNS prophylaxis、HD-MTX、ultra high-risk、retrospective multicenter。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要明确记录 1,923 例超高危 LBCL 中，HD-MTX 未显著降低总体 CNS 复发、孤立 CNS 复发或 6 个月 landmark 人群 的 CNS 复发。

论文作者观点

论文作者观点：尽管回顾性研究有固有限制，这一最大规模国际比较数据集强烈支持既往研究，即 HD-MTX 预防对大多数患者没有有意义获益。

我的推断

我的推断：后续 DLBCL CNS 风险研究应把 CNS 预防从“是否给 HD-MTX”推进到更精细的生物学风险、CNS 穿透策略和毒性-获益平衡；不能把该研究解读为所有个体均不需要 CNS 风险管理。

Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2026 Jun 11 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42274647/>

STARGLO 3 年随访：固定疗程 glofitamab-GemOx 在 ASCT 不适合 R/R DLBCL 中持续优于 R-GemOx

PMID 42269085

打开 PubMed 文献

Glofitamab plus gemcitabine and oxaliplatin for relapsed/refractory DLBCL: 3-year follow-up of STARGLO.

双抗 / CD20xCD3 / R/R DLBCL ASCT 不适合 R/R DLBCL EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-12 近 7 天新增入库/发表/更新

P ASCT 不适合的 R/R DLBCL 患者

I glofitamab + gemcitabine + oxaliplatin

C rituximab + gemcitabine + oxaliplatin

O OS、PFS、CR、亚组疗效、安全性新信号

结论

STARGLO III 期研究 3 年随访显示，glofitamab 联合吉西他滨/奥沙利铂（Glofit-GemOx）相较 R-GemOx 继续带来 OS、PFS 和 CR 率优势，且未发现新的安全性信号。获益在二线、早期治疗失败/原发难治及老年患者亚组中仍可见，强化了 CD20xCD3 双抗作为 R/R DLBCL 即用型固定疗程方案的研究价值。

主要内容

- 研究对象为 ASCT 不适合的 R/R DLBCL 患者；比较 Glofit-GemOx 与 R-GemOx。
- 中位 OS 随访 35.1 个月后，中位 OS 为 25.5 vs 12.5 个月，HR 0.60；中位 PFS 为 14.4 vs 3.3 个月，HR 0.41。
- CR 率为 58.5% vs 25.3%；二线患者 3 年 OS 率为 54.6%，三线及以后为 33.2%。
- 二线原发难治或早期治疗失败患者 36 个月 OS 率为 46.1% vs 16.5%；≥75 岁老年患者也观察到一致疗效，未见新安全性信号。

关键信息

- 作者：Jeremy S Abramson、William Townsend、Christopher P Fox、Matthew Ku、Mark Hertzberg、Hui-Qiang Huang 等。
- 核心数据：OS 25.5 vs 12.5 月；PFS 14.4 vs 3.3 月；CR 58.5% vs 25.3%。
- 方案价值：固定疗程、off-the-shelf 双抗联合化疗，适合与 CAR-T 可及性、桥接和序贯问题共同讨论。
- 方向标签：glofitamab、CD20xCD3 bispecific、GemOx、STARGLO、R/R DLBCL、ASCT-ineligible。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录 STARGLO 3 年随访中 Glofit-GemOx 相比 R-GemOx 在 OS、PFS 和 CR 率上持续占优，且未发现新的安全性信号。

论文作者观点

论文作者观点：固定疗程 Glofit-GemOx 在 ASCT 不适合 R/R DLBCL 中是有效的即用型治疗，二线、早复发/难治和老年患者亚组尤其值得关注。

我的推断

我的推断：后续研究设计应把 Glofit-GemOx 放进二线策略、CAR-T 不可及/等待期、以及早期失败人群的序贯比较框架中；不能把亚组信号直接写成跨地区通用治疗推荐。

R/R LBCL CAR-T 中氟达拉滨暴露窗口：前瞻性 PK 监测提示 AUC 适中者 PFS 更优

Impact of fludarabine exposure on CAR T-cell outcomes in patients with large B-cell lymphoma.

PMID 42269079

打开 PubMed 文献

CAR-T / lymphodepletion / 药代

R/R large B-cell lymphoma

EDAT/PDAT/MDAT 命中; 2026-06-12 近 7 天新增入库/发表/更新

P

接受商业 CD19 CAR-T 的 R/R LBCL 患者

I

淋巴清除期间氟达拉滨 AUC 监测并识别最佳暴露窗口

C

处于最佳 AUC 窗口 vs 未处于最佳 AUC 窗口

O

PFS、CAR-T 扩增、CRS、ICANS、血液毒性

结论

这项前瞻性单中心研究在 R/R LBCL 商业 CD19 CAR-T 患者中测量淋巴清除期间氟达拉滨暴露，并为 axi-cel 和 tisa-cel 分别识别出最佳 AUC 窗口。处于最佳暴露窗口的患者中位 PFS 未达到，而其他患者为 13.3 个月；多变量分析中最佳暴露仍与更优 PFS 独立相关，且 CRS、ICANS 和血液毒性发生率相似。

主要内容

- 研究纳入 54 例接受商业 CD19 CAR-T 的 R/R LBCL 患者，中位随访 24.5 个月。
- 每位患者淋巴清除期间最多采集 7 个血浆样本，用群体 PK 模型估计氟达拉滨 AUC。
- 最佳 AUC 窗口为 axi-cel 17.5-21.5 mg*h/L, tisa-cel 14.0-18.0 mg*h/L; 24 例 (44%) 落在对应窗口内。
- 最佳窗口组 PFS 未达到 vs 13.3 个月, p=0.03; CAR-T 扩增和 CRS、ICANS、血液毒性发生率与非窗口组相近。

关键信息

- 作者：Mario Andrés Sánchez-Salinas、Javier Varela-Gonzalez-Aller、Gloria Iacoboni、Victor Navarro、Iñaki F Troconiz、Cecilia Carpio 等。
- 核心变量：fludarabine AUC、axi-cel/tisa-cel 产品特异窗口、PFS、CAR-T 扩增、CRS/ICANS/血液毒性。
- 研究价值：把 CAR-T 前处理从固定剂量经验推进到药代引导剂量优化假设。
- 方向标签：CD19 CAR-T、LBCL、fludarabine、lymphodepletion、PK-guided dosing、AUC window。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录最佳氟达拉滨 AUC 窗口与更长 PFS 独立相关，同时未观察到 CAR-T 扩增和主要毒性发生率的明显差异。

论文作者观点

论文作者观点：前瞻性测量氟达拉滨暴露可识别与更优 CAR-T 结局相关的产品特异 AUC 窗口，支持整合 PK 引导的氟达拉滨给药。

我的推断

我的推断：CAR-T 研究可把淋巴清除暴露量作为可调控研究变量，而不是仅记录前处理方案名称；但当前样本量为 54 例单中心，仍需多中心验证后才能形成剂量规则。

EBV+ DLBCL 免疫生物学：系统抗病毒 T 细胞缺陷与 LMP1 驱动的抑制性髓系生态位共同塑形

Loss of systemic anti-viral immunity and LMP1-driven suppressive myeloid tumour niches converge to shape the immunobiology of Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma.

PMID 42271039

打开 PubMed 文献

免疫微环境 / EBV+ DLBCL / 转化机制

EBV 阳性 DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-12 近 7 天新增入库/发表/更新

P

EBV+ DLBCL 患者及 EBV- DLBCL、EBV+ cHL、传染性单核细胞增多症和健康对照

I

抗病毒 T 细胞功能、空间蛋白组学和 LMP1 相关机制建模

C

EBV+ DLBCL 与 EBV- DLBCL、其他 EBV 相关状态及健康对照

O

T 细胞耗竭/调节、CD8+ T 细胞密度、PD-L1+/IDO1+ 巨噬细胞生态位、LMP1 空间关联

结论

这项 Leukemia 研究整合外周抗病毒 T 细胞功能、高维空间蛋白组学和体外机制模型，显示 EBV+ DLBCL 不只是免疫衰老问题，而是系统性抗病毒免疫功能障碍与 LMP1 相关抑制性肿瘤微环境共同作用。EBV+ DLBCL 中 CD8+ T 细胞减少、PD-1+ 调节/耗竭 T 细胞扩增、PD-L1+/IDO1+ 巨噬细胞聚集，并且抑制性髓系生态位富集在 LMP1 表达肿瘤细胞周围。

主要内容

- 研究比较 EBV+ DLBCL、EBV- DLBCL、EBV+ 经典霍奇金淋巴瘤、传染性单核细胞增多症和健康对照相关免疫状态。
- EBV+ 和 EBV- DLBCL 患者均较健康对照存在广泛抗病毒 T 细胞反应损害，EBV+ 患者缺陷最明显。
- 空间蛋白组学显示 EBV+ DLBCL 有显著免疫抑制微环境：肿瘤内 CD8+ T 细胞相对减少，PD-1+ 调节/耗竭 T 细胞增加。
- PD-L1+/IDO1+ 巨噬细胞密集聚集，且优先富集在 LMP1 表达肿瘤细胞周围，提示病毒蛋白与髓系抑制生态位存在空间联系。

关键信息

- 作者：Éanna Fennell、Soi C Law、Alexander C Dowell、Matthew R Pugh、Christina M Enright、Aisling M Ross 等。
- 核心技术：外周抗病毒 T 细胞功能分析、高维空间蛋白组学、体外机制建模。
- 机制价值：把 EBV+ DLBCL 从年龄相关免疫衰老扩展为 “系统抗病毒免疫缺陷 + 局部髓系免疫抑制” 。
- 方向标签：EBV+ DLBCL、LMP1、PD-L1、IDO1、macrophage niche、T-cell exhaustion、spatial proteomics。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录 EBV+ DLBCL 中抗病毒 T 细胞反应缺陷、CD8+ T 细胞减少、PD-1+ 调节/耗竭 T 细胞扩增和 PD-L1+/IDO1+ 巨噬细胞聚集。

论文作者观点

论文作者观点：EBV+ DLBCL 由系统性抗病毒免疫功能障碍与 LMP1 依赖的抑制性肿瘤微环境共同驱动。

我的推断

我的推断：EBV+ DLBCL 的免疫治疗研究不应只看 PD-1/PD-L1 单指标，可预设 LMP1 空间邻近、髓系生态位和外周抗病毒 T 细胞功能作为联合分层变量。

DLBCL 肿瘤来源 HMGB2 外泌体轴：TRIM65 介导 NLRP3 降解，推动 M2 样巨噬极化和抗 CD20 耐受

Tumor-derived HMGB2 induces M2-like macrophage polarization via TRIM65-mediated NLRP3 degradation to promote DLBCL progression.

免疫治疗机制 / 巨噬细胞 / DLBCL 耐药

DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-12 近 7 天新增入库/发表/更新

P DLBCL 公共数据、细胞系、动物模型及巨噬细胞-DLBCL 共培养系统

I HMGB2 knockdown 或靶向 HMGB2-TRIM65-NLRP3 轴

C HMGB2 高表达/未干预状态与 knockdown/靶向干预状态

O 肿瘤进展、巨噬细胞极化、吞噬功能、CD20 免疫治疗协同效应

结论

这项 Journal for ImmunoTherapy of Cancer 研究显示，HMGB2 在 DLBCL 中过表达并与较差预后相关。DLBCL 细胞来源外泌体 HMGB2 可上调巨噬细胞 TRIM65，促进 NLRP3 炎症小体泛素化降解，驱动 M2 样极化并削弱吞噬功能。靶向该轴可恢复巨噬细胞吞噬，并与 CD20 免疫治疗协同增强抗肿瘤效应。

主要内容

- 作者利用公共数据库、qRT-PCR、western blot、体内外 HMGB2 knockdown 模型和巨噬细胞-DLBCL 共培养系统分析 HMGB2 的作用。
- HMGB2 knockdown 在体外未显示明显细胞内在效应，但在体内显著抑制肿瘤进展，提示主要通过重塑肿瘤微环境发挥作用。
- 机制上，DLBCL 来源外泌体 HMGB2 上调巨噬细胞 E3 泛素连接酶 TRIM65，促进 NLRP3 炎症小体泛素化降解。
- 该级联反应驱动 M2 样巨噬细胞极化、削弱吞噬功能；靶向该轴恢复吞噬并与 CD20 免疫治疗产生协同。

关键信息

- 作者：Sanxiu He、Yi Liu、Yifeng Tang、Liuyue Zhai、Xin Luo、Mingyu Zhao 等。
- 核心机制：exosomal HMGB2 -> TRIM65 -> NLRP3 degradation -> M2-like macrophage polarization -> phagocytosis impairment。
- 治疗启示：不是单药临床证据，而是提示抗 CD20 免疫治疗耐受可由微环境吞噬功能低下驱动。
- 方向标签：DLBCL、HMGB2、TRIM65、NLRP3、macrophage polarization、phagocytosis、CD20 immunotherapy。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要记录 HMGB2 过表达与较差预后相关，外泌体 HMGB2 通过 TRIM65 介导 NLRP3 降解，导致 M2 样巨噬极化和吞噬受损。

论文作者观点

论文作者观点：HMGB2-TRIM65-NLRP3 轴是 DLBCL 关键免疫抑制通路，靶向该轴可能作为重编程微环境、克服治疗耐受的联合策略。

我的推断

我的推断：DLBCL 免疫治疗方案设计可把巨噬细胞吞噬功能、外泌体蛋白和 NLRP3/TRIM65 状态纳入转化终点；但目前仍属于机制和前临床联合假设，不能写成已验证治疗方案。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方候选池 280 条，精选 5 篇未跨日重复 PMID：42274647、42269085、42269079、42271039、42270158。已验证证据覆盖 HD-MTX 在超高危 LBCL CNS 预防中未显著降低 CNS 复发、STARGLO 3 年随访中 Glofit-GemOx 持续优于 R-GemOx、CAR-T 前处理氟达拉滨 AUC 窗口与 PFS 相关、EBV+ DLBCL 的系统抗病毒免疫缺陷和 LMP1 相关髓系生态位，以及 HMGB2-TRIM65-NLRP3 轴导致巨噬细胞吞噬受损。	论文作者观点 入选论文作者共同强调，R/R DLBCL 新治疗证据正在从单纯反应率推进到固定疗程双抗生存获益、CAR-T 前处理暴露量优化、CNS 预防真实获益再评估、病毒相关免疫生态位和巨噬细胞介导耐受机制。作者观点总体支持把治疗路径、药代、空间免疫微环境和生物标志物并入研究设计。	我的推断 我的推断是，今天最值得后续跟踪的不是单个药名，而是“策略变量”：CNS 预防是否真正降低事件、双抗在二线/不可移植人群的位置、CAR-T 淋巴清除是否需要 PK 引导、EBV+ DLBCL 是否需要抗病毒免疫和髓系生态位联合分层、抗 CD20 耐受是否可通过恢复巨噬吞噬来转化。所有推断仅用于文献监测和研究设计启示，不构成治疗推荐。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。